

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063260-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ELIZANGELA PEREIRA VIANA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER o presente recurso, ante a perda superveniente de objeto. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

5063260-54.2024.4.02.5101

510014278405 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063260-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ELIZANGELA PEREIRA VIANA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (evento 93, DESPADEC1):

"Trata-se de ação judicial proposta por Elizangela Pereira Viana, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora objetiva a realização de consulta em Cirurgia Geral - Hérnia, com a respectiva cirurgia de Hérnia Incisional, além do tratamento cirúrgico de fístulas e do exame de tomografia computadorizada de pelve / bacia / abdômen inferior, sob o argumento de que foi submetida à histerectomia em julho de 2022, que evoluiu com fístula vesico vaginal, apresentando volumosa hernia incisional, necessitando realizar procedimento cirúrgico para correção.

É o necessário. DECIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), para fins de apreciação dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela (tutela de urgência), devem estar presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso sob exame, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença concomitante de ambos os requisitos que justifique a tutela de urgência neste momento, a partir dos esclarecimentos prestados nos autos.

*Remetidos os autos ao Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NATJUS/RJ, o referido Órgão técnico, no parecer constante do Evento 7, informou o seguinte: i) "no que tange ao **tratamento cirúrgico de fístulas** pleiteado, de acordo com sumário de alta do Hospital Universitário Gafreë e Guinle, datado de 25/10/2023 (Evento 1, ANEXO2, Página 10), consta atendimento na especialidade de urologia, evidenciando como motivo da internação/diagnóstico principal na alta/diagnósticos secundários, fístula vesico vaginal com estado de resolução: resolvido. Consta ainda no referido documento, orientação de retorno no dia 14/11/2024, para retirada de cateterismo vesical de demora e reavaliação (Evento 1, ANEXO2, Página 10). Ressalta-se que nos documentos médicos acostados ao processo, não foi solicitado o*

procedimento de correção de fistula”; ii) “quanto ao **procedimento cirúrgico** pleiteado cirurgia de hérnia incisional, informa-se que somente após a avaliação do especialista, na consulta em cirurgia geral, poderá ser definido o plano terapêutico mais adequado ao caso da Autora.”; e iii) “no intuito de identificar o correto encaminhamento da Autora nos sistemas de regulação, este Núcleo consultou as Plataformas do Sistema de Regulação SISREG III e Sistema Estadual de Regulação – SER, sendo localizado (ANEXO):

- Solicitação **495025325** em 16/09/2023, inserida pelo Centro Municipal de Saúde Carlos Alberto Nascimento AP 52, para o procedimento **consulta em cirurgia geral - hérnia**, classificação de risco **amarelo** - urgência, **agendada** para QUA - **25/10/2023** - 08h30min no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, com aviso: “Paciente avisado ... 23/10/2023 08:15:58” e situação atual: **agendamento/falta/executante**.

- Solicitação **518594961** em 08/02/2024, inserida pelo Centro Municipal de Saúde Carlos Alberto Nascimento AP 52, para o procedimento **tomografia computadorizada de pelve ou bacia**, classificação de risco **amarelo** - urgência, **agendado** para QUA - **08/05/2024** - 10h40min, com aviso: “Paciente avisado ... 04/04/2024 13:46:19”, Justificativa: “Paciente atendido no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle dia 12/12/2023. Descrição do diagnóstico: hérnia ventral sem obstrução. Solicitado utilização de contraste venoso...” e situação atual: **solicitação/autorizada/regulador**.”

Consoante o referido parecer, a via administrativa está sendo utilizada para o procedimento “tomografia computadorizada”, sendo, entretanto, interrompida para consulta em cirurgia geral - hérnia.

Noticiou a parte autora que já realizou a cirurgia das fístulas (Evento 19) e, posteriormente, o exame de tomografia (Evento 79), encontrando-se pendente a realização da cirurgia de hérnia incisional.

No curso do processo, foram prestadas informações pelo Hospital Universitário Gaffrée Guinle, com indicação de realização de consultas e com informação de que, na última realizada, não havia condições ideais para a realização da cirurgia, de maneira que foi determinada nova consulta para fins de reavaliação no último dia 07/08/2024 (Evento 65).

Por último, após informações prestadas pela parte autora (Evento 79), este Juízo determinou nova intimação do Hospital Universitário, que prestou as seguintes informações: a) a paciente foi atendida na Clínica Cirúrgica A do HUGG, com indicação de muita dor, mas, após exames, constatou-se que a dor era desproporcional ao exame físico que não apresentava sinais de obstrução ou de complicações agudas, nem dor quando da palpação profunda (Evento 91, OFIC2); b) mesmo assim, realizou-se tomografia computadorizada, que não demonstrou sinais de complicações da hérnia volumosa, sendo a paciente incluída em uma fila de prioridades e será operada nos próximos 30 dias (encontra-se na posição 32, mas será priorizada). No particular, note-se que a Autora tomou ciência desse prazo informado (Evento 91, OFIC3, página 30).

Dessa forma, entendo que, por ora, a via administrativa está sendo utilizada, sem prejuízo de posterior realização de prova pericial, para fins de exame do quadro clínico da parte autora e da premente necessidade do procedimento cirúrgico almejado, caso não seja efetivada a cirurgia pelo Nosocômio supracitado no prazo informado.

Friso, ainda, o seguinte: i) não compete a este Juízo determinar qual tratamento deve ser prescrito à parte autora pelo Estado, sendo certo que tal tipo de decisão é privativa dos Médicos da Rede Pública de Saúde, ou mesmo de médicos particulares; e (ii) não cabe a esta magistrada a indicação de determinada Unidade Hospitalar, a não ser que seja, de forma demonstrada, a única apta ao tratamento pleiteado (neste sentido, cito o Enunciado nº 66 do FOREJEF da 2ª Região).

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos da fundamentação.

Defiro a gratuidade de justiça requerida pela parte autora.

Citem-se os Réus para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade na qual deverão se manifestar sobre a possibilidade de conciliação, e trazerem aos autos qualquer documento que tenham em seu poder que seja útil ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.259/01.

Ressalto que a parte autora deverá informar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, se houve a realização do procedimento cirúrgico almejado, tal como apontado pelo Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (Evento 91, OFIC2 e OFIC3, página 30)."

VOTO

Compulsando os autos originários, verifico ter sido proferida sentença extintiva, em 05/09/2024, em razão realização do procedimento cirúrgico (evento 130, SENT1).

Desta forma, entendo configurada a perda de objeto no presente caso.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER o presente recurso, ante a perda superveniente de objeto**. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa.

